

时间：

“1” 或 “24”
1. 两床之间的距离不少于 1m;
2. 特级护理：24h 专人护理;
3. 无菌持物镊在手术室，门诊换药室，注射室一般每日更换一次;
4. 开启后的无菌溶液、无菌容器、无菌包 24h 更换一次;
5. 临时医嘱：医嘱有效时间在 24 小时以内;
6. 严重的哮喘发作持续 24 小时以上，经治疗不易缓解者，称之为哮喘持续状态。
7. 子宫体与子宫颈之间形成的最狭窄部分称为子宫峡部，在非孕期长约 1cm;
8. 母婴同室指产后母婴 24 小时在一起，母婴分离不应超过 1 小时;
9. 滞产：指总产程超过 24 小时。
10. 分娩 24 小时后，在产褥期内发生的子宫大量出血，称晚期产后出血。
11. 绝经是指月经完全停止 1 年以上;
12. 葡萄胎清宫术后禁止性生活 1 个月，以防止感染：坚持避孕 1 年，避孕方法最好选用工具;
13. 围绝经期保健：指导避孕至停经 1 年以上;
14. 宫内节育器绝经 1 年后取出。

二、

1. 约束带（一般每 2 小时松解一次）；
2. 高原地区气压低，沸点低，需适当延长煮沸时间，一般海拔每增高 300m，煮沸时间延长 2 分钟。
3. 预防压疮：一般每 2 小时翻身一次；
4. 低盐饮食：成人摄入食盐不超过 2g/d。
5. 吸碘试验饮食：检查或治疗前 2 周，禁食含碘量高的食物；
6. 2 周后做 ^{131}I 功能测定。
7. 鼻饲量每次不应超过 200ml，间隔时间不少于 2 小时。
8. 软组织损伤早期（48h）：禁用热疗；
9. 正常瞳孔：在自然光线下，瞳孔直径为 2~5mm；
10. 胚胎发育 2~8 周为心脏形成的关键时期；
11. 迁延性腹泻病程 2 周~2 个月。
12. 直径小于 2mm 的细支气管称为小气道；
13. 医院获得性肺炎：在入院 48 小时后在医院内发生肺炎；
14. 抗病毒治疗（奥司他韦）应在发病 48 小时内；
15. 分娩后继续在产房内观察 2 小时。
16. 子宫破裂者 2 年内不宜再次妊娠。
17. 肾实质切开取石及肾部分切除的病人，应绝对卧床 2 周；
18. 肾损伤：绝对卧床休息 2~4 周；
19. 休克是烧伤后 48 小时内导致病人死亡的主要原因。

20. 发现甲类传染病和按照甲类管理的乙类传染病病人、病原携带者或疑似传染病病人时，应在 2 小时内报告发病地的卫生防疫机构。

三：

1. 护理诊断的陈述包括三个要素：问题(P)，即护理诊断的名称；症状或体征(S)；相关因素(E)，多用“与……有关”来陈述。又称为 PSE 公式。
2. 病人的传染性分泌物经三次培养，结果均为阴性或确已度过隔离期，经医生开出医嘱方可解除隔离。
3. 口腔测温与直肠测温时间：3 分钟后取出；
4. 胆囊 B 超检查饮食：检查前 3 日晚餐进无脂肪、低蛋白、高碳水化合物、清淡的饮食，以减少胆汁分泌。
5. 潜血试验饮食：试验前 3 天禁食肉类、动物血、肝脏、含铁剂药物及绿色蔬菜，以免产生假阳性反应。
6. 水银体温计的检查方法：方法：将所有体温计的水银柱甩至 35℃ 以下，于同一时间放入已经测试过的 40℃ 以下的温水内，3 分钟后取出检视。若读数相差 0.2℃ 以上、玻璃管有裂隙、水银柱自动下降的体温计则取出，不再使用。
7. 便秘是指大便次数减少，一般每周少于 3 次；
8. 术前 3 天，每晚用 300~500ml 温等渗盐水洗胃。
9. 阑尾周围脓肿病人出院后 3 个月，后可行阑尾切除术。
10. 腹外疝：术后 3 个月避免重体力劳动或提举重物。
11. 妊娠 3 个月以内的孕妇等禁忌接种；.

12. 复发性流产：指同一性伴侣连续发生 3 次或 3 次以上的自然流产。每次流产多发生于同一妊娠月份。

13. 总产程不足 3 小时称为急产；

14. 肾病综合征：钠的摄入量不超过 3g/d。

15. 肋骨骨折病人 3 个月后复查 X 线片，以了解骨折愈合情况。

16. 腰椎间盘突出症：3 个月内不作弯腰持物活动；

17. 肩关节脱位：固定：复位后将肩关节固定于内收、内旋、屈肘 90° ，用三角巾悬吊于胸前，固定 3 周；

18. 乳腺癌根治术后 3 个月行乳房再造术；

19. 首次护士执业注册：护士首次执业注册应当自通过护士执业资格考试之日起 3 年内提出；

20. 急性感染心内膜炎病人应在入院后 3 小时内，每隔 1 小时 1 次共取 3 个血标本后开始治疗；

四：

1. 四轻：说话轻、走路轻、操作轻、关门轻。

2. 无菌持物镊干燥存放 4 小时一次；

3. 铺好的无菌盘不得超过 4 个小时；

4. 一次性口罩不得超过 4 小时；

5. 对高热病人应每隔 4 小时测一次体温；

6. 发热时体温每升高 1°C ，呼吸每分钟增加约 4 次。

7. 灌肠：中暑病人可用 4℃ 的 0.9% 氯化钠溶液。
8. 氧气筒：“四防”，即防震、防火、防热，防油；距火炉至少 5m、暖气 1m。
9. 出生后 4 周内为新生儿期；
10. 子宫脱垂 I 度：宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，未达处女膜缘，称为轻型；
11. 中暑高热伴休克时降温措施可动脉快速推注适量 4℃ 5% 葡萄糖盐水。
12. 蛛网膜下腔出血病人应绝对卧床 4 周
13. 公众距离：4m 以上
14. 破伤风抗毒素过敏试验阳性：硬结大于 1.5cm，红晕超过 4cm，
15. 白细胞浓缩悬液：于 4℃ 环境下保存，48 小时内有效。
16. 产褥期：产后 4h 内排尿
17. 活跃期停滞：进入活跃期后，宫口不再扩张 ≥ 4h
18. 产褥病率：指分娩 24 小时以后的 10 日内，每日测量体温 4 次，间隔时间 4 小时，有 2 次体温 ≥ 38℃
19. 血压计四定：定时间，定部位，定体位，定血压计
20. 急腹症四禁：禁食禁饮，禁止痛剂，禁热敷，禁灌肠；

五：
1. 急救物品应做到“五定”，即定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌及定期检查维修，使急救物品完好率达到 100%。
2. 对婴幼儿、老年人、昏迷、末梢循环不良、麻醉未清醒、感觉障碍等病人，热水袋的水温应调至 50℃ 以内；

3. 需留尿培养标本，用无菌标本瓶或试管接取中段尿 5ml；
4. 血培养标本：一般血培养取血 5ml；亚急性细菌性心内膜炎病人，应取血 10～20ml；
5. 粪便常规留取标本：便盆内，用检便匙在粪便中央部分取或取黏液、脓血等异常部分，量约 5g。
6. Reynolds 五联征：腹痛，寒战高热，黄疸，精神症状和休克。
7. 麻疹：出疹前 5 天至出疹后 5 天均有传染性。
8. 乳腺癌术后 5 年内应避免妊娠；
9. 护士执业注册有效期和变更注册有效期均为 5 年。

六：
1. 日光曝晒法：曝晒 6 小时；
2. 正常人尿液呈弱酸性，PH4.5～7.5，平均值为 6。
3. 抢救病人时的口头医嘱需要在抢救结束后 6h 内补齐；
4. 6 小时内洗胃效果最好
5. 安装心脏起搏器的患者。指导病 6 周内限制体力活动；
6. 高血压病人每日食盐量不少于 6g；
7. 食管上连咽部，约起于第 6 颈椎平面；
8. 生理性腹泻多见于 6 个月以下婴儿；
9. 孕妇在妊娠 6 周左右出现恶心、晨起呕吐等早孕反应，12 周左右消失。
10. 从胎盘娩出至产妇除乳腺外全身各器官恢复至非孕期状态的一段时期称为

产褥期，一般为 6 周。

11. 胎盘附着处子宫内膜修复的时间为 6 周（非胎盘附着处修复时间为 3 周）；

12. 纯母乳喂养可至生后 6 个月。

13. 侵蚀性葡萄胎发生在葡萄胎清除后 6 个月内。

七：

1. 近期目标:指需较短时间就能实现的目标，一般少于 7 天。

2. 留观时间一般为 3~7 天。

3. 无菌物品，如无菌包，无菌容器等，在未被污染的情况下，有效期 7 天；

4. 无菌持物镊病房一般一周换一次；

5. 妊娠 7 个月以上的孕妇禁用盆浴；

6. 普通胃管每周更换 1 次，硅胶胃管每月更换 1 次。

7. 血清病型反应:一般于用药后 7~12 天发生，临床表现和血清病相似，病人有发热、皮肤瘙痒、荨麻疹、腹痛、关节肿痛、全身淋巴结肿大等。

8. 留置针一般可保留 3~5 天，最多不超过 7 天。

9. 初乳是指产后 7 天内分泌的乳汁；

4 ~ 6	
洗胃时间	4 ~ 6h
正常恶露的持续时间	4 ~ 6周
辅食开始添加的时间	4 ~ 6个月
心脏骤停后，发生大脑不可逆的损害的时间	4 ~ 6min
小儿腹泻呕吐严重者禁食（不禁水）	4 ~ 6h
中性粒细胞和淋巴细胞的两次交叉(比例相等)	第一次交叉出现在生后 4--6天;第二次交叉出现在 4--6岁

“6~8”
1. 去枕仰卧位：椎管麻醉或腰椎穿刺术后 6~8 小时的病人，用于防止颅内压降低所引起的头痛。
2. 密闭式输液法：止血带的位置：在穿刺点上方 6~8cm（消毒直径 $\geq$ 5cm）；
3. 循环负荷过重（急性肺水肿，急性左心衰）：氧流量 6~8L/min；
4. 血栓闭塞性脉管炎术后病人应平卧位，穿刺点加压包扎 24 小时，患肢制动 6~8h。
5. 新生儿低血糖，可按 6~8mg/(kg·min) 速率输注葡萄糖；
6. 清创术应争取在伤后 6~8 小时内施行；
7. 小儿气管异物取出前需禁食 6~8h；

30 分钟
1. 定时开窗通风，每次 30 分钟。
2. 冷疗时间不得超过 30 分钟；为病人测肛温，每 30 分钟一次；
3. 青霉素首次注射后应观察 30 分钟
4. 癫痫持续状态是指一次癫痫发作持续 30 分钟以上，或连续多次发作、发作间期意识或神经功能未恢复至正常水平。
5. 压力性损伤的预防：一般每 2 小时翻身一次，必要时每 30 分钟翻身一次。
6. 降低体温：降温 30 分钟后，应该复测体温。
7. 测温前 20~30 分钟若有运动、进食、冷热饮、冷热敷、洗澡、坐浴、灌肠等，应休息 30 分钟后再测量。

8. 测量脉搏：测量前 30 分钟无过度活动，无紧张、恐惧等。
9. 降温灌肠时液体保留 30min，排便后 30min，测量体温并记录。
10. 臭氧消毒：消毒后开窗通风 ≥ 30 分钟后人员方可进入
11. 无菌技术操作原则：操作前 30 分钟应停止清扫工作
12. 连续使用雾化器，中间应间隔 30 分钟。
13. 冰袋降温：为高热患者降温，用冷 30min 后测量体温
14. 温水擦浴和乙醇擦浴：擦浴后 30 分钟测量体温
15. 脑震荡：意识丧失时间不超过 30 分钟
16. 脑挫裂伤：意识障碍时间超过 30 分钟
17. 第三产程：此产程需 5~15 分钟，一般不超过 30 分钟
18. 开奶时间：出生后 30 分钟内

公式：

熏蒸法空气消毒
1. 纯乳酸使用量=房间长度 $\times$ 宽度 $\times$ 高度 $\times 0.12\text{ml}$
2. 食醋使用量=房间长度 $\times$ 宽度 $\times$ 高度 $\times (5\sim 10)\text{ml}$
3. 钾溶液量：钾溶液量=补液总量 $\times 0.3\% \div$ 钾溶液浓度
4. 滴速计算每分钟滴数=液体的总量(m1) $\times$ 滴系数(滴/毫升)/输液所用时间(分钟) 溶液每毫升的滴数称为滴系数，一般为 15 滴/毫升
5. 吸氧浓度和氧流量换算法吸氧浓度(%)=21+4 $\times$ 流量(L/min)
6. 烧伤面积头颈 9%=头 3%+面 3%+颈 3%；双上肢 18%=双手 5%+双前臂 6%+

双上臂 7%；躯干 27%=前躯干 13%+后躯干 13%+会阴部 1%；双下肢 46%=臀 5%+双大腿 21%+双小腿 13%+双足 7%。12 岁以下小儿：头部面积=21-年龄，双下肢面积=34+年龄)

7. 小儿体重 3~12 个月：体重(kg)=(月龄+9)/2×0.7；

1~6 岁：体重(kg)=年龄×2+8

8. 小儿身高 2~6 岁，身高(cm)=年龄(岁)×7+75(cm)

9. 牙齿数量 2 岁内乳牙数目为月龄减 4~6。

10. 骨化中心：年龄+1

11. 小儿血压 2 岁以后收缩压=(年龄×2+80)mmHg；舒张压=收缩压×2/3

12. 老年人运动后最宜心率：心率(次/分)=170-一年龄

13. 预产期推算末次月经第 1 天起，月份减 3 或加 9，日期加 7

14. 基础代谢率(BMR)测定 BMR%=脉压+脉率-111

15. 体重指数(BMI) BMI=体重/身高的平方

16. 乙醇配比计算： $C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$ (如：已知现有 75%的乙醇，需配制用于皮肤按摩消毒 50%的乙醇 50ml，则需取用 75%乙醇的量为多少？)(计算为： $50\% \times 50 = 75\% \times V_2$)

其他：

首选青霉素治疗的疾病：破伤风、猩红热、肺炎球菌感染、风湿热。

葡萄糖酸钙的应用：链霉素过敏、输库存血、高血钾引起的心肌抑制、甲状旁腺误切引起抽搐(发作时静注)、VitC 缺乏性手足抽搐(镇静同时缓慢推注)、

硫酸镁中毒。

恶性肿瘤的治疗方法：除白血病、绒毛膜癌、浸润性葡萄胎，小细胞肺癌外，其他均首选手术治疗。

碳酸氢钠的作用：

1%-2%的碳酸氢钠可提高沸点，去污防锈；

1%-4%可用于口腔真菌感染，

2%-4%可用于外阴阴道假丝酵母菌病的阴道冲洗，

2%的碳酸氢钠可用于鹅口疮患儿口腔清洗。

5%用于奶瓶消毒

敌百虫农药中毒禁用碳酸氢钠洗胃（会被氢化成毒性更强的敌敌畏）。

乙醇浓度	作用
20%-30%	急性肺水肿时湿化给氧，从而降低肺泡内泡沫的表面张力
30%	湿润、松解头发缠结
25%-35%	乙醇擦浴
50%	皮肤按摩，百部液的配置
75%	体温计消毒（80%药效降低）
95%	燃烧法消毒和静脉炎湿敷

出血量	临床表现
>5ml	大便隐血试验阳性

50ml	黑便
250ml	呕血
>1000ml	休克

肺部叩诊音	肺含气量	常见疾病
清音	正常	正常
过清音	增多	支气管哮喘、肺气肿
鼓音	明显增多	气胸
浊音	减少	肺炎
实音	明显减少	胸腔积液

“先后要有序

1. 挪动法的搬运：上车下床

2. 床上擦浴穿脱衣服：脱衣一先近后远(外伤先健后患)；

穿衣一先远后近(外伤先患后健)

3. 超声雾化吸入法：开时一先电源再雾量

关时一先流量后电源

4. 吸氧：使用时一先流量再插管

停用时——先拔管再开关

5. 冬眠低温疗法：开始一先药物再物理

结束一先物理再逐渐停药物

惊厥抽搐用药	新生儿首选苯巴比妥
	子痫首选硫酸镁
	其余首选地西泮
	低钙者补钙

氧流量	常见的疾病
0.5~1L/min	小儿肺炎鼻导管给氧
1~2L/min	COPD、肺心病、二型呼吸衰竭（持续低浓度低流量给氧）
2~4L/min	右心衰竭给氧、小二肺炎缺氧严重时面罩吸氧
4~5L/min	有机磷农药中毒时给氧
6~8L/min	急性肺水肿
5~10L/min	CO 中毒时，给氧浓度>60%
氧气浓度与流量的换算公式	吸氧浓度=21+4×吸氧流量

传染病隔离	
疾病	隔离措施
鼠疫、霍乱、SARS	严密隔离
伤寒、痢疾、甲肝、戊肝	消化道隔离
乙肝、丙肝、AIDS（艾滋病）	血液隔离

破伤风、炭疽、丹毒	接触隔离
乙脑、疟疾	昆虫隔离
大面积烧伤、白血病、艾滋病（晚期）、 早产儿、器官移植（大白爱早起）	保护性隔离

BMI=体重（kg）/身高（m） ²	
18.5~24	正常
<18.5	消瘦
24.0~27.9	超重
≥28	肥胖

靴型心	主动脉瓣关闭不全，法洛四联症
普大型心	扩张型心肌病，全心衰
梨形心	二尖瓣狭窄
烧瓶心	心包积液

扁平胸	肺结核
桶状胸	肺气肿
漏斗胸、鸡胸	佝偻病

类型	补盐量
低盐饮食	<2g/d
正常人	<6g/d
高血压	<6g/d
急性肾小球肾炎急性期	<3g/d
肾病综合征	低盐饮食(钠<3g/d)
慢性心力衰竭	2~3g
肝硬化腹水	2g/d
无盐低钠饮食	钠<0.5g/d

肿瘤	常见病理类型	常见转移方式	临床表现
甲状腺癌	乳头状癌	淋巴转移	单个、质地硬而固定、表面高低不平，随吞咽上下移动的肿块
食管癌	鳞癌	淋巴转移	早期表现:哽噎感 典型表现:进行性吞咽困难
胃癌	腺癌	淋巴转移 (左锁骨上淋巴结)	早期无表现;常有上腹隐痛(体征)
胰腺癌	导管细胞腺癌	淋巴转移	上腹饱胀不适(最常见;首发症状) 进行性黄疸(最主要体征);
大肠癌	大体分型:溃疡癌	淋巴转移	早期表现:排便习惯改变

	组织学分型：腺癌		典型表现：黏液脓血便（直肠癌）
膀胱癌	-	淋巴转移	无痛间歇性全程血尿
乳腺癌	-	淋巴转移	早期：无痛单发肿块；酒窝征；皮肤：橘皮样改变 晚期：皮肤溃疡；铠甲状
肺癌	腺癌	淋巴转移	刺激性干咳带金属音、痰中带血
肾癌	透明细胞癌	血性转移至肺	无痛间歇性全程血尿+腰痛+腹部肿块
绒毛膜癌，侵蚀性葡萄胎	滋养细胞肿瘤	血性转移至肺	葡萄胎清宫术后出现不规则阴道流血
肝癌	大体分型：结节型 组织学：肝细胞型	肝内血性转移	最主要症状：肝区持续性胀痛； 最主要体征：进行性肝大
子宫内膜癌	腺癌	直接浸润	绝经后阴道流血
子宫颈癌	大体分型：外生型 组织学分型：鳞癌	直接浸润	早期表现：接触性出血

300-500ml	
洗胃	300~500ml/次（25~38℃）
瘢痕性幽门梗阻	术前3日，每晚用300~500ml 温生理盐水洗胃，以减轻胃壁水肿和炎症
膀胱容量	300~500ml

去枕仰卧位	全身麻醉未清醒或昏迷患者：可防止呕吐物流入气管，引起窒息或肺部感染 椎管内麻醉或脊髓腔穿刺后6~8小时的患者：防止颅内压降低引起头痛
中凹卧位	抬高头胸部约 10° ~20°，抬高下肢约 20° ~30°。用于休克患者
屈膝仰卧位	腹部检查或导尿及会阴冲洗
侧卧位	①灌肠、肛门检查及配合胃镜检查等（老年人）； ②预防压疮； ③臀部肌肉注射时，下腿弯曲，上腿伸直
半坐卧位	①某些面部及颈部手术后病人：减少局部出血。 ②胸腔疾病、胸部创伤或心肺疾病引起呼吸困难的病人：改善呼吸困难； ③腹腔、盆腔手术后或有炎症的病人：促进炎症局限； ④腹部手术后病人：减轻腹部切口张力； ⑤疾病恢复期体质虚弱的病人：适应体位变化，向站立过渡
端坐位	适用范围：左心衰竭、心包积液、支气管哮喘发作

俯卧位	①脊椎手术后或腰、背、臀部有伤口； ②腰、背部检查或配合胰、胆管造影检查时。 ③胃肠胀气所致腹痛的病人
头低足高位	①十二指肠引流，有利于胆汁排出。 ②肺部分泌物引流，有利于痰液咳出。 ③产妇胎膜早破时，防止脐带脱垂。 ④跟骨或胫骨结节牵引
头高足低位	①降低颅内压，预防脑水肿。 ②颅脑手术后 ③颈椎骨折患者进行颅骨牵引时
膝胸卧位	①矫正子宫后倾或胎位不正。 ②促进产后子宫复原。 ③肛门、直肠及乙状结肠的检查和治疗（年轻人）
截石位	①会阴与肛门部位检查、治疗或手术等，如膀胱镜、妇产科检查、阴道灌洗等。 ②产妇产后
蹲位	检查直肠脱垂、内痔及直肠息肉

疾病	临床或心电图特点	治疗
窦性心动过速	窦性心律频率>100次/分	不需特殊治疗
窦性心动过缓	窦性心律频率<60次/分	不需特殊治疗
房性期前收缩	P波提早出现，QRS波群形态正常	对因处理
室性期前收缩	QRS波群提前出现，形态宽大畸形，T波常与QRS波群的主波方向相反	利多卡因
阵发性室性心动过速	3个或3个以上连续出现的室性期前收缩	胺碘酮
室上性心动过速	突发突止，持续时间长短不一	腺苷、颈动脉窦按摩
房颤	窦性P波消失，代之以大小形态不一且不规则的f波，频率 350~600次/分	同步直流电复律
室颤	P-QRS-T波消失	非同步直流电复律

温度	适用
2~6℃	库存血的保存温度。白蛋白制剂的保存温度
4℃	中暑灌肠;白细胞浓缩悬液(48小时内有效),中暑高热伴休克(5%葡萄糖盐水)
2~8℃	未开封胰岛素保存
15~20℃	破伤风病室
18℃以下	新鲜冰冻血浆和冰冻血浆的保存温度
18~20℃	儿童病房
18~22℃	一般病室温度
20~24℃	血小板浓缩悬液的保存温度(24小时内有效)
22~24℃	新生儿及老年人、产房、手术室
24~26℃	早产儿病室
25~38℃	洗胃
26~28℃	分娩室室温
28~32℃	降温灌肠
30℃	乙醇擦浴;肛温不可低于最低温度
30~32℃	烧伤暴露疗法
33℃	冰槽降温肛温维持;
35℃	易发生中暑的温度
32~34℃	温水擦浴
36~37℃	腋下温度
36.3~37.2℃	口腔温度
36.5~37.7℃	直肠温度
38.0~40℃	膀胱冲洗(基础护理学);前列腺增生:25-30℃
38.0~40℃	鼻饲及要素饮食(口服37℃)
40~45℃	热水坐浴;外科:43-46℃
43~46℃	温水浸泡
不超过50℃	超声雾化吸入水槽内温度;
50~52℃	床上擦浴
50~60℃	热湿敷
60~70℃	热水袋(50℃:昏迷,老年人,末梢循环不良)

外文缩写	中文译意	外文缩写	中文译意	外文缩写	中文译意
qm	每晨1次	hs	临睡前	DC	停止
qn	每晚1次	ac	饭前	PO	口服
qd	每日1次	pc	饭后	ID	皮内注射
bid	每日2次	st	立即	H	皮下注射
tid	每日3次	q4h	每4h 1次	IM	肌肉注射
qid	每日4次	sos	必要时(限用1次, 12h有效)	IV/iv/ivgtt/ivdrip	静脉注射/静脉滴注
qod	隔日1次	prn	需要时(长期)	pulv	粉剂/散剂

蛋白尿	尿蛋白超过150mg/d
镜下血尿	每高倍镜视野红细胞超过3个
肉眼血尿	洗肉水样、血样、酱油样（1L尿含1ml血液）
白细胞尿 / 脓尿	每高倍镜视野白细胞超过5个
菌尿	尿细菌培养菌落计数超过 10^5 /ml

疾病	最早表现
青霉素过敏	呼吸道症状和皮肤瘙痒
慢性呼吸衰竭	呼吸困难
慢性肾衰竭	消化系统表现：食欲减退、腹部不适
急性白血病	贫血
吉兰-巴雷综合征	四肢对称迟缓性无力
低钾血症	肌无力
肺癌	阵发性刺激性干咳
原发性肝癌	肝区疼痛
食管癌	哽噎感、异物感
大肠癌	排便习惯及粪便性状的变化
胰腺癌	上腹痛
乳腺癌	单发无痛性肿块
良性前列腺增生	尿频、尿急
腰椎间盘突出症	腰痛
小儿营养不良	体重不增

疾病	确诊辅助检查
支气管扩张	高分辨 CT
肺结核	痰结核分枝杆菌检查
心律失常	心电图
先天性心脏病、心脏瓣膜病、心肌病	超声心动图

冠心病、下肢静脉曲张	血管造影
感染性心内膜炎	血培养
系统性红斑狼疮	抗双链 DNA 抗体
消化性溃疡、食管癌、胃癌、大肠癌、膀胱癌	纤维内镜
肝癌、宫颈癌、乳腺癌	活组织检查
肾癌	CT 检查
异位妊娠	阴道后穹窿穿刺
子宫内膜癌	分段诊断性刮宫
子宫内膜异位症	腹腔镜检查
葡萄胎、侵蚀性葡萄胎、绒毛膜癌	绒毛膜促性腺激素 (HCG) 测定
早期妊娠、前置胎盘、胎盘早剥、子宫肌瘤	B 超检查

新生儿硬肿发生顺序	小腿—大腿外侧—整个下肢—臀部—面颊—上肢—全身
麻疹出疹顺序	耳后发际—面—颈—躯干—四肢—手掌和足底
水痘出疹顺序	头—面—躯干—四肢，向心性分布（躯干多，四肢少）
猩红热出疹顺序	耳后，颈部及上胸部开始，迅速蔓延至全身
破伤风累及肌肉顺序	咀嚼肌—面肌—颈项肌—腹、背肌—四肢肌—呼吸肌

类型	处理
休息与体位	①小量咯血：静卧休息 ②大量咯血：绝对卧床，取患侧卧位，有利于健侧肺的通气功能 ③咯血伴窒息：取头低足高45° 俯卧位
饮食	①小量咯血：进少量温、凉流质饮食 ②大量咯血：禁食
其它	大咯血：可用垂体后叶素可收缩小动脉，减少肺血流量，从而减轻咯血，但冠心病、高血压病人及孕妇忌用

疾病	慢性胃炎	胃溃疡	胃癌
病因	幽门螺杆菌		
临床表现	上腹部饱胀不适	进食-疼痛-缓解	早期无症状，粪便隐血试验阳性
检查	胃镜	胃镜+取活检	胃镜+取活检
治疗	三联疗法：两种抗生素+质子泵抑制剂 四联疗法：两种抗生素+质子泵抑制剂+枸橼酸铋钾	①药物治疗 ②手术治疗	手术治疗

疾病	心绞痛	心肌梗死
诱发因素	情绪激动、饱餐、寒冷、吸烟	无
疼痛部位	胸骨体中段或上段	与心绞痛相似
疼痛时间	3~5分钟，一般不超过15分钟	数小时到数天
辅助检查	心电图	1. 心电图： ①宽而深的Q波 ②ST段抬高呈弓背向上型 2. 实验室检查：肌红蛋白（最早） 肌钙蛋白：最特异
治疗原则	立即休息，同时舌下服用硝酸甘油	①抗凝治疗：阿司匹林 ②室颤：非同步电复律 ③疼痛：吗啡

管型尿	定义：若12小时尿沉渣计数管型超过5000个，或镜检发现大量或其他类型管型，称为管型尿
	白细胞管型：活动性肾盂肾炎的特征
	上皮细胞管型：急性肾小管坏死
	红细胞管型：急性肾小球肾炎
	颗粒管型：肾病综合征
	蜡样管型：慢性肾衰竭

疾病	临床表现
异位妊娠	停经+腹痛+阴道流血（伴有休克失血量大）+阴道后穹窿穿刺
前置胎盘	妊娠 28 周后+无诱因、无痛性阴道流血
胎盘早剥	妊娠 20 周后或分娩期+突发腹痛
妊娠期高血压	首次出现 $BP \geq 140/90\text{mmHg}$ +尿蛋白（-）
轻度子痫前期	$BP \geq 140/90\text{mmHg}$ +尿蛋白 $\geq 0.3\text{g}/24\text{h}$
重度子痫前期	$BP \geq 160/110\text{mmHg}$ +尿蛋白 $\geq 2.0\text{g}/24\text{h}$
先兆子宫破裂	产妇剧烈腹痛、病理性缩复环、胎心减慢或触摸不清、血尿
子宫颈癌	接触性出血，即性生活或妇科检查后阴道流血
子宫内膜癌	绝经后阴道出血
子宫内膜异位症	继发性痛经且进行性加重
子宫肌瘤	经量增多及经期延长

疾病	要点
COPD	①气流受限不完全可逆 ②慢性咳嗽咳痰：最早症状 ③逐渐加重的呼气性呼吸困难：典型 ④体征：桶状胸，过清音 ⑤并发症：Ⅱ型呼吸衰竭，自发性气胸，肺心病 ⑥检查：肺功能检查（ $FEV_1/FVC < 0.7$ ） ⑦低流量（ $1 \sim 2\text{L}/\text{min}$ ）低浓度（ $25\% \sim 29\%$ ）持续吸氧 ⑧家庭氧疗：低流量吸氧 $1 \sim 2\text{L}/\text{min}$ ，吸氧时间 >15 小时/天 ⑨缩唇呼吸：鼻吸口呼，深吸缓呼，呼与吸时间比例为 $2:1 \sim 3:1$
肺心病	①病因：COPD ②病理改变：肺动脉高压 ③主要因素：缺氧 ④临床特点：呼衰，右心衰 ⑤并发症：肺性脑病（死因）

A组乙型溶血性链球菌	风湿热、心脏瓣膜病、急性肾炎、猩红热、蜂窝织炎、淋巴管炎
肺炎链球菌	肺炎
草绿色链球菌	亚急性感染性心内膜炎
金黄色葡萄球菌	急性感染性心内膜炎、疖、痈、脓性指头炎、化脓性骨髓炎
大肠埃希菌	夏季腹泻、细菌性肝脓肿、尿路感染（肾盂肾炎）
轮状病毒	秋季腹泻
厌氧菌	产褥感染
白色念珠菌	鹅口疮、外阴阴道假丝酵母菌病
幽门螺旋杆菌（HP）	慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌
柯萨奇A组病毒	疱疹性咽峡炎
柯萨奇B组病毒	扩张型心肌病、病毒性心肌炎
肠道病毒	病毒性脑膜炎
麻疹病毒	麻疹
水痘-带状疱疹病毒	水痘
人类免疫缺陷病毒	艾滋病
乙脑病毒	乙脑
痢疾杆菌	细菌性痢疾
脑膜炎球菌	流行性脑脊髓膜炎

传染病	传染性	传播途径	临床表现	患者需隔离	密切接触者需观察
流行性脑脊髓膜炎	10天内	飞沫传播	高热，皮肤出现瘀点瘀斑	症状消失后3d	7
流行性腮腺炎	发病前6天到后9天	飞沫传播	腮腺肿大（首发）	腮腺肿大消退后3d	21
麻疹	①出疹前、后的5天 ②有并发症的患者可延长至出疹后10天	飞沫传播	①麻疹黏膜斑（早期诊断） ②最初见于耳后发际、为淡红色充血性斑丘疹	出疹后5d	21
水痘	出疹前1~2天至病损结痂为止	飞沫传播	①不同性状的皮疹同时存在是水痘皮疹的重要特征（四世同堂） ②皮疹为向心性分布，躯干多，四肢少 ③黏膜疱疹可出现在口腔、咽、结膜和生殖器等处 ④水痘为自限性疾病，一般10日左右自愈	出疹后7d或疱疹全部结痂	21
猩红热	发病前24小时至疾病高峰	飞沫传播	针尖大小的充血性皮疹，压之褪色，触之有砂纸感，疹间无正常，皮肤帕氏线口周苍白圈	症状消失后7d	7
细菌性痢疾		消化道传播	感染性休克，黏液脓血便	症状消失后7d	7

程度	痰量	咯血	血胸
轻度	<10ml/d	<100ml/d	<500ml
中度	10~150ml/d	100~500ml/d	500~1000ml/d
重度	>150ml/d	>500ml/d（100ml/次）	>1000ml/d

卧位	
左侧卧位	灌肠；洗胃；空气栓塞（左侧头低足高位）；妊娠；慢性白血病 巨脾
右侧卧位	鼻饲；小儿为防止溢乳；阿米巴痢疾灌肠
患侧卧位	咯血；胸痛；支气管痿管；全肺切除术（1/4患侧卧位）、颅底骨折
健侧卧位	会阴伤口；肺叶切除术；肺段切除术；楔形切除术、肾结石

无菌技术	
24h	4h
无菌包（已开封）	无菌盘
无菌容器（已开封）	无菌口罩
无菌溶液（已开封）	无菌持物钳（干燥存放）

疾病	要点
缺铁贫	①铁丢失过多： 慢性失血 ；铁摄入不足：妇女、儿童 ②吸收部位：十二指肠及空肠上段 ③临床表现： 皮肤黏膜苍白（最突出） ；反甲（匙状甲） ⑤检查： 小细胞低色素性贫血 ⑥治疗：病因治疗（ 基本 ），补铁治疗：两餐之间或 餐后服用
巨幼贫	①病因：缺乏 维生素 B₁₂或（和）叶酸 ②表现：患儿外观虚胖，面色苍黄或蜡黄，记忆力减退 ③检查： 大细胞性贫血 ④治疗：补充维生素B ₁₂ 和叶酸
再障贫	①本质：骨髓造血功能衰竭 ②病因： 氯霉素 （最主要） ③表现：a. 重型再障 ： 出血和感染 为主；b. 非重型再障： 贫血 为主 ④检查： 正细胞正色素贫血 ⑤治疗：重型再障：免疫抑制剂；非重型再障： 雄激素（刺激肾脏产生促红细胞生成素

免疫球蛋白	应用
IgM	早期感染的指标； 乙型脑炎 ；类风湿关节炎；甲肝病毒感染早期指标
IgG	保护性抗体；唯一能够通过 胎盘 的免疫球蛋白
IgE	过敏性疾病： 支气管哮喘 ；药物过敏试验；寄生虫病：胆道蛔虫病
IgA (SIgA)	母乳

	急性肾炎	慢性肾炎 (3个月)	肾病综合征	急性肾盂肾炎	急性肾损伤	慢性肾衰竭
表现	以血尿为主	以蛋白尿为主 (150mg)	大量蛋白尿 (> 3.5g/d)	以寒战、高热为主	以少尿、无尿为主	消化系统症状为首发表现
其他症状	①蛋白尿、 ②水肿 (肾小球滤过率下降) ③高血压 (水钠潴留)	与急性肾炎相似	①低蛋白血症 ②水肿 (血浆胶体渗透压下降) ③高脂血症	膀胱刺激征：尿频、尿急、尿痛	高钾血症 (死因)	①贫血 (促红细胞生成素减少) ②高钾血症或低钾血症 ③高磷、低钙血症 ④代谢性酸中毒

疾病	药物
循环系统	
慢性心力衰竭	①强心 (洋地黄)：增强心肌收缩力，减慢心率 ②利尿：呋塞米、螺内酯 ③血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI)：可以减缓心室重构
急性心力衰竭	镇静 (吗啡)、利尿 (呋塞米)、扩血管 (硝普钠)、强心 (毛花苷)、平喘 (氨茶碱)
高血压	①利尿剂：呋塞米 (不良反应：低血钾)，氢氯噻嗪 (不良反应：低血钾、高尿酸血症，痛风患者禁用) 螺内酯 (保钾利尿剂) ②B受体阻滞剂：洛尔类 (作用：减慢心率。不良反应：心动过缓，支气管哮喘禁用) ③钙通道阻滞剂：硝苯地平 (不良反应：头痛，面色潮红) ④血管紧张素转换酶抑制剂 (ACEI)：卡托普利【不良反应：刺激性干咳 (可用沙坦类药物)】
高血压危象	硝普钠 (避光滴注)
心绞痛	硝酸甘油 (舌下含服)
急性心肌梗死	①止痛：哌替啶 (肌肉注射)、吗啡 (皮下注射) ②溶栓：尿激酶、链激酶 (6h内使用) ③急性心梗 24h内不使用洋地黄
心脏骤停	肾上腺素：增加全身循环阻力
室上速 (了解)	腺苷

室速	胺碘酮
房颤	同步电复律

室颤	①非同步电复律；②利多卡因：治疗和预防的心室颤动首选药物
呼吸系统	
肺炎链球菌肺炎	青霉素
支原体肺炎、衣原体肺炎	大环内酯类抗生素（红霉素）
支气管哮喘	①激动控症： β_2 受体激动剂（沙丁胺醇雾化吸入）：控制症状的首选药 ②抗炎吃糖：糖皮质激素（控制哮喘最有效的抗炎药物） ③解喘饮茶：氨茶碱（松弛支气管平滑肌；不良反应：胃肠道症状，低血压） ④预防色狼：色甘酸钠（预防哮喘复发）
呼吸衰竭	呼吸兴奋剂（尼可刹米、洛贝林）
消化系统	
鹅口疮	制霉菌素
溃疡性口炎	5%金霉素鱼肝油、利多卡因（止痛）
疱疹性口炎	碘苷（抑制病毒）、2.5%~5%金霉素鱼肝油、利多卡因（止痛）
慢性胃炎	根除幽门螺杆菌： ①三联疗法：2种抗生素+铋剂/质子泵抑制剂（PPI） ②四联疗法：2种抗生素+铋剂+质子泵抑制剂（PPI）
消化性溃疡	①抑制胃内酸度的药物： H_2 受体拮抗剂（雷尼替丁）、质子泵阻滞剂（奥美拉唑是目前最强的胃酸分泌抑制剂）、制酸剂（氢氧化铝） ②保护黏膜的药物：枸橼酸铋钾、硫糖铝 ③胃肠动力药：吗丁啉（多潘立酮）；西沙比利
溃疡性结肠炎	氨基水杨酸制剂（柳氮磺吡啶 SASP）
急性胰腺炎、胆道疾病	禁用吗啡，以免引起 Oddi 括约肌痉挛；可选用：哌替啶/阿托品
上消化道出血	垂体后叶素
泌尿系统	
肾病综合征	糖皮质激素
营养性缺铁性贫血	口服铁剂（两餐之间服用）
巨幼细胞贫血	维生素 B12 和（或）叶酸
再生障碍性贫血	①非重型再障：雄激素；②重型再障：免疫抑制剂
特发性血小板减少性紫癜	肾上腺糖皮质激素（泼尼松）

白血病	①环磷酰胺：出血性膀胱炎； ②柔红霉素：心率加快，心率失常 ③长春新碱：末梢神经炎、手足麻木 ④甲氨蝶呤：口腔溃疡 ⑤中枢神经系统白血病：甲氨蝶呤 ⑥慢性粒细胞白血病：羟基脲
弥散性血管内凝血(DIC)	肝素（过量用鱼精蛋白中和）
内分泌	
单纯性甲状腺肿	碘剂
甲状腺功能亢进症	甲巯咪唑（首选）
甲状腺危象	丙硫氧嘧啶 PTU
甲状腺功能减退症	左甲状腺素
营养不良	苯丙酸诺龙（促进蛋白质的合成和增进食欲）
佝偻病	维生素 D：①治疗量：800IU/d；②预防量：400IU/d
糖尿病	①磺脲类：直接刺激胰岛 B 细胞释放胰岛素（不良反应：低血糖），饭前半小时服用 ②二甲双胍：最适合超重的 2 型糖尿病，作用：通过增加外周组织对葡萄糖的摄取和利用。餐时或餐后 ③α-葡萄糖苷酶抑制剂：阿卡波糖（拜糖平）。应与第一口饭同时嚼服
急性痛风性关节炎	秋水仙碱

风湿性疾病	
风湿热	①一般治疗：苄星青霉素。 ②抗风湿治疗：首选药物非甾体类抗炎药（阿司匹林）； ③心脏炎：糖皮质激素治疗（泼尼松）
系统性红斑狼疮（SLE）	糖皮质激素，盘状狼疮（磷酸氯喹）
传染病	
流行性感冒	奥司他韦（48 小时内使用）
水痘	阿昔洛韦（24 小时内使用）
细菌性痢疾	喹诺酮
流行性脑脊髓膜炎（流脑）	青霉素
肝炎	甲肝：注射人免疫球蛋白 新生儿（乙肝）：乙肝疫苗+高效价乙肝免疫球蛋白注射
艾滋病	①核苷类反转录酶抑制剂：齐多夫定（首选） ②肺孢子菌肺炎：复方磺胺甲异恶唑
肺结核	①异烟肼：周围神经炎 ②利福平：肝功能损害 ③链霉素：听力障碍、肾功能损害

	④吡嗪酰胺：胃肠道不适 ⑤乙胺丁醇：视神经炎 一周以后练听力，利肝安胃肠
--	--

神经系统	
三叉神经痛	卡马西平
帕金森	左旋多巴
癫痫持续状态	地西泮
癫痫大发作	丙戊酸钠
脑水肿	20%甘露醇 250ml 静脉快速滴注
损伤、中毒	
肉芽组织	①肉芽水肿：可用 5%氯化钠溶液湿敷。
烧伤	晶体液（电解质）：平衡盐；胶体液：血浆
蛇咬伤	胰蛋白酶（分解蛇毒）
有机磷中毒	①毒蕈碱症状（M 样）：阿托品 ②烟碱样症状（N 样）：胆碱酯酶复能剂（碘解磷定或氯解磷定）
酒精中毒	①维生素 B1、B6（加速乙醇在体内氧化） ②纳洛酮：保护脑功能
中暑	①氯丙嗪：药物降温； ②中暑高热伴休克时，降温措施可动脉快速推注适量 4℃5% 葡萄糖盐水
淹溺	①淡水淹溺：3%氯化钠溶液 ②海水淹溺：5%葡萄糖溶液或低分子右旋糖酐
细菌性食物中毒	①沙门菌：喹诺酮类或氯霉素等； ②副溶血性弧菌：氯霉素和四环素或喹诺酮类等； ③大肠杆菌感染：阿米卡星
破伤风	①中和游离毒素：破伤风抗毒素（TAT） ②冲洗伤口：3%过氧化氢； ③控制并解除痉挛：地西泮； ④预防感染：青霉素； ⑤儿童：破伤风类毒素，获得自动免疫
骨质疏松	①女性：雌激素； ②阿仑磷酸钠片：空腹服用，服用后多饮水